Autos nº 0801542-89.2023.8.12.0006

Autor(es): José Dutra Costa

Réu(s): Estado de Mato Grosso do Sul e Municipio de Camapuã

Sentença.

Vistos, etc...

José Dutra Costa ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face do Estado de Mato Grosso do Sul e Municipio de Camapuã, todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é portador de Noeplasia Maligna da próstata (CID C61). Em decorrência da patologia que lhe acomete, ele necessita fazer uso do medicamento, Enzalutamida 40mg, segundo prescrição oncológica e documentos anexos.

Argumentou que o fármaco oferece possibilidade de aumento de sobrevida global livre de progressão da doença, não havendo medicamento equivalente disponível no SUS.

Salientou que não tem condições para arcar com o tratamento, orçado no valor mensal aproximado de R$ 13.838,00 (treze mil oitocentos e trinta e oito reais), elevando frente aos parcos rendimentos com os quais sobrevive sua família, sendo necessário a quantia de R$ 83.028,00 (oitenta e três mil, e vinte e oito reais), para custear o tratamento por 06 (seis) meses.

Com a inicial vieram os documentos de f. 9/39

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico foi desfavorável ao pedido (f. 41/50).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela (f. 51/52).

Sentença de procedência às f. 149/155.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul (f. 164/184).

V. Acórdão que reconheceu a nulidade da r. Sentença, entendendo pela ocorrência de cerceamento de defesa (f. 248/252).

Facultada às partes a produção probatória (f. 267), a parte autora pugnou pela produção de prova pericial (f. 275), enquanto os entes federativos requereram o julgamento antecipado do feito (f. 274 e 277).

Deferida a produção de prova pericial, ficando nomeada perita de confiança deste Juízo (f. 278/279).

Apresentada proposta de honorários periciais no valor de R$ 2.400,00 (f. 294/298), com a qual as partes expressamente concordaram.

Laudo pericial encartado às f. 360/371.

Manifestação do Estado de Mato Grosso do Sul (f. 379/383), do Município de Camapuã (f. 387/391) e da parte autora (f. 385/386).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

É, de fato, caso de julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, tendo em vista que a matéria posta é de direito e a matéria fática com alguma relevância não reclama necessidade de produção de outras provas.

DAS PRELIMINARES

I - Ilegitimidade passiva – necessidade de inclusão da União no polo passivo – aplicação do tema 793/STF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Como é sabido, o Sistema Único de Saúde - SUS é composto pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, impondo-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar tratamento médico.

A saúde é direito de todos e dever do Estado no sentido *latu sensu*, o qual deverá envidar todos os esforços necessários para que a aludida garantia constitucional seja atendida de maneira eficiente, com o fornecimento de medicamentos e a aplicação de tratamento médico específico aos cidadãos que deles necessitem.

Os arts. 196 e seguintes da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 23, II, da Constituição Federal é claro ao estabelecer a legitimidade dos demandados para figurarem no polo passivo da demanda, criando uma competência comum e concorrente entre os entes federativos com relação às questões de saúde e assistência pública.

Neste sentido, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça "segundo o qual, a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário, mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo" (AgRg no Resp 1164933/RJ)

Se tanto não bastasse, cumpre assinalar que o art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal dispõe que o Sistema Único de Saúde será firmado, nos termos do art. 195, com recursos da Seguridade Social advindos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Não é outro o espírito da Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (Sistema Único de Saúde) ao atribuir, a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

todos os entes federados, a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão optar por aquele que lhe prestará assistência.

A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública é integral e conjunta, vale dizer, compartilhada e decorre do texto constitucional, podendo a parte autora escolher contra quem oferecerá a ação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

> *"TJMS-012638) MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - DEVER DO ESTADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.Possui legitimidade passiva para o writ a autoridade que, ao prestar informações, não se restringe a alegar sua ilegitimidade, pois contesta o mérito e defende a constitucionalidade e a legalidade do ato praticado por seu subordinado.* ***Tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas para responder à ação de obrigação de fazer destinada a compelir o ente estatal a prover, gratuitamente, a aquisição de medicamentos indicados por facultativo, para o tratamento de enfermidades que põem em risco a saúde do cidadão hipossuficiente****. Compete ao Estado de Mato Grosso do Sul dispensar ao paciente o medicamento prescrito pelo profissional médico que orienta o tratamento, no caso, o Plavix 75 mg, na dosagem prescrita.(Mandado de Segurança nº 2006.001793-1, 1ª Seção Cível do TJMS, Rel. Josué de Oliveira. j. 22.05.2006).****Grifei."***

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o tema 793, extraído do RE nº 855178, entendeu pela possibilidade de qualquer dos entes federados figurarem no polo passivo, isolada ou conjuntamente, senão vejamos:

> *"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

> *REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.* ***O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."*** *(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)*

Com efeito, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Assim, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação, de modo que a questão sobre o repasse de verbas atinentes deve ser dirimida administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Ainda que assim não fosse e, apesar da divergência jurisprudencial acerca da responsabilidade ou não da União nas demandas que versam sobre medicamento não incluído na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME), mas devidamente registrado na Anvisa, é certo que, em 13/06/2022, a Primeira Seção do STJ admitiu o Incidente de Assunção de Competência nº 14, para dirimir a controvérsia, deliberando que, até o julgamento definitivo daquele incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao dos autos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023, referendou, por unanimidade, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n 1.366.243/SC (Tema 1234), que determinou que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, *"nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo".*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Com isto, afasto a preliminar.

II - Impugnação à justiça gratuita.

Os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento no sentido de que para ser caracterizado como necessitado, não significa que a parte deva andar descalça ou não possuir bens, bastando, para tanto, simplesmente uma declaração de que a mesma não possa dispor dos valores referentes ao pagamento das despesas e encargos processuais, sem que falte o essencial a sua família.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência pátria, *in verbis*:

> *"JUSTIÇA GRATUITA - Concessão - Beneficiário possuidor de imóvel - Irrelevância - Fato que não prova a suficiência de recursos - Declaração de pobreza, ademais, juntada aos autos, satisfazendo o exigido pelas Leis 7.155/83 e 1.060/50 - provido"* [1]

> *"A condição de pobreza, enquanto requisito da concessão do benefício da justiça gratuita, adscrevendo-se à impossibilidade de custeio do processo, sem prejuízo próprio ou da família, não sofre com a circunstância eventual de a parte ter bens, móveis ou imóveis, se esses nada lhe rendem, ou se o que rendem não lhe evitaria aquele prejuízo."* [2]

No caso vertente, a parte demandada/impugnante não produziu qualquer prova para elidir a condição de pobreza na forma prevista na Constituição Federal e na Lei, haja vista que não carreou aos autos qualquer documento para demonstrar que a requerente possua altos rendimentos ou grande patrimônio.

Desta forma, ausente prova em contrário, *"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"*, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC.

[1] (TJSP - Rel. Villa da Costa - Agravo de Instrumento nº 183.680-1 - Pedreira - 10.02.93)
[2] (AI 162.627-1/8, 4.2.92, 2a. CC TJSP, rel. Des. CEZAR PELUSO, in RT 678/88).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Portanto, não existe nos autos nenhuma razão pela qual não deva ser mantida a concessão da assistência judiciária gratuita deferida à demandante.

Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo ente demandado.

III – **Da preliminar de incorreção do valor da causa.**

O requerido alega que nas demandas de saúde o proveito econômico é inestimável, por tratar-se de direito fundamental, sendo necessária a correção do valor da causa.

Sabe-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, de modo que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação.

Desta forma, na ação em que se objetiva a concessão de medicamento para uso contínuo, o valor da causa corresponderá ao valor anual do fármaco, conforme prevê o art. 292 , § 2º , do CPC.

In casu, o que se busca é o tratamento com a medicação pelo período de seis meses, a qual possui um custo exato, que originou o valor da causa, o qual, por sua vez, reflete o conteúdo econômico perseguido na demanda. Assim, não há que se falar em incorreção do valor da causa, de modo que rejeito a referida preliminar.

MÉRITO

Infere-se dos autos a alegada omissão do Município de Camapuã-MS e do Estado de Mato Grosso do Sul no fornecimento de tratamento de saúde a parte autora, a qual necessita de tratamento com Enzalutamida 40mg, em razão de ser portador de Noeplasia Maligna da próstata (CID C61).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Pois bem.

É oportuno registrar que o direito pleiteado na exordial perpassa pela consideração de que a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, representa o valor supremo que deverá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, mormente dos direitos e garantias fundamentais.

Posto isso, não se pode descurar que o direito à saúde é assegurado a todos os brasileiros, como direito social, previsto no art. 6º da Constituição Federal, *in verbis*:

> *"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."*

Ademais, a Constituição Federal ainda prescreve, em seu art. 196, que *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"*.

Nesse passo, estabelecido que a saúde representa direito constitucionalmente assegurado a todos, incumbe ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício.

É oportuno transcrever a seguinte ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

> *"O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.

O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República" (RE 273.834/RS, rel. Min. Celso de Melo, DJ 18.09.00)"

Em que pese o reconhecimento do direito fundamental à saúde, não se pode olvidar que, com a constante mutação e evolução da sociedade, passou-se a enfrentar considerável dificuldade em se identificar seus efeitos e limites, conforme ensinamentos de Ingo Sarlet, Daniel Mitidiero e Luiz Guilherme Marinoni:

"Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de um direito à saúde, venham a opor além da já clássica alegação de que o direito à saúde (a exemplo dos direitos sociais prestacionais em geral) foi positivado como norma de eficácia limitada os habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos públicos, não nos parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a preservação do bem maior da vida humana. O que se pretende realçar, por ora, é que, principalmente no caso do direito à saúde, o reconhecimento de um direito originário a prestações, no sentido de um direito subjetivo (individual ou mesmo coletivo, a depender do caso) a prestações materiais (ainda que limitadas ao estritamente necessário para a proteção da vida humana), diretamente deduzido da Constituição, constitui exigência inarredável da própria condição do direito à saúde como direito fundamental, ou seja, como trunfo contra a maioria, muito embora com isso não se esteja a sustentar que o direito à saúde possa ser considerado como um direito ilimitado a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

> *qualquer tipo de prestação estatal."* (SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Ao buscar uniformização de entendimento sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça realizou o julgamento do Recurso Especial n.º 1657156/RJ, ao qual se afetou o Tema 106 de Recurso Repetitivo (qual seja: *"Obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS"*, a saber, os medicamentos não contemplados na Portaria n.º 2.982/2009 do Ministério da Saúde e as respectivas alterações promovidas através de portarias e atos administrativos posteriores).

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com modulação de efeitos:

> *A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.* (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, na tentativa de racionalizar a concessão excessiva de medicamentos pelo Poder Judiciário e estabelecer critérios objetivos para análise dessas demandas, editou as Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61, de observância obrigatória em se tratando de pleito de fornecimento de medicamentos não incorporados junto ao SUS, as quais preconizam o seguinte:

> *"Súmula vinculante n.º 60: O pedido e a análise administrativos de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante n.º 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

No que tange ao Tema 6 do STF, foram fixadas as seguintes teses:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19- Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Em relação ao Tema 1.234, o STF estabeleceu o que segue:

> *"IV Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS).*
>
> *4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*
>
> > *4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidadecom as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.*
> >
> > *4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.*
> >
> > *4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.*
> >
> > *4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

> *alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise."*

Portanto, para que o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS seja julgado procedente, a parte autora deverá comprovar os seguintes requisitos: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n.º 8.080/90 e no Decreto n.º 7.646/11; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Estabelecidas essas premissas, após examinar os elementos probatórios carreados ao caderno processual, verifica-se que a parte requerente não faz jus ao recebimento do medicamento "Enzalutamida 40mg ".

No que tange à negativa administrativa, observa-se que a parte autora não carreou aos autos o comprovante de postulação administrativa do medicamento. Todavia, a própria contestação do réu demonstra a resistência ao pleito, razão pela qual reputo atendido tal requisito.

Entretanto, o parecer do NAT consigna que o medicamento almejado pela parte autora não está padronizado na RENAME (item VII):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

VII - Se o pedido do autor é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em qualquer esfera, considerando especialmente, no caso de fármacos, os Programas de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Protocolos Clínicos e a eficácia dos remédios disponibilizados na rede pública;

A Enzalutamida não está padronizada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) ou outro ato normativo do SUS, bem como não foi avaliada pela CONITEC.

Ademais, o parecer do NAT esclareceu que há opção de tratamento farmacêutico ao medicamento pleiteado pela parte autora, senão vejamos: *"Os membros da CONITEC presentes na reunião do plenário do dia 06/06/2019 deliberaram, por unanimidade, por recomendar a Abiraterona para câncer de próstata metastático resistente à castração, em pacientes com uso prévio de quimioterapia, conforme a Assistência Oncológica no SUS. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 453/2019. Decisão: Incorporar a abiraterona para o câncer de próstata metastático resistente à castração de pacientes com uso prévio de quimioterapia, conforme a Assistência oncológica no SUS, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Dada pela Portaria nº 38, publicada no Diário Oficial da União nº 142, seção 1, página 147, em 25 de julho de 2019."*.

Nesse mesmo sentido, o laudo pericial (f. 360/371) aduziu o seguinte:

2. *Comparação de Eficácia:* A literatura médica e as notas técnicas da CONITEC indicam que não há superioridade comprovada da Enzalutamida sobre a Abiraterona em termos de Sobrevida Global (desfecho duro). Ambas são consideradas opções de primeira linha equivalentes pelas diretrizes médicas (SBU/SBOC).

3. *Parecer da CONITEC:* A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) emitiu recomendação desfavorável à incorporação da Enzalutamida, justamente por considerar que a Abiraterona já atende à necessidade terapêutica com melhor relação custo-efetividade.

Em continuidade, a perita foi clara ao estabelecer que "embora o paciente tenha respondido bem à Enzalutamida, não foram identificados documentos médicos que comprovem contraindicação absoluta ao uso da Abiraterona (como insuficiência hepática grave ou intolerância a corticóides), ou falha terapêutica prévia a este fármaco fornecido pelo SUS".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Neste jaez, a perita concluiu que "***(...) sob a ótica técnica e regulatória, existe alternativa terapêutica disponível na rede pública com eficácia comparável que não foi, documentalmente, descartada por razões clínicas de ineficácia ou toxicidade***".

Nesse contexto não há evidências de ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, uma vez que existem outros medicamentos padronizados para tratamento das doenças que acometem a parte autora.

Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou, por meio de estudos clínicos satisfatórios, que o referido fármaco possui eficácia e a segurança necessárias ao tratamento de que necessita. Tampouco que as alternativas oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento.

Recorde-se que, para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, não basta a apresentação de simples relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível.

Diante desse contexto, tem-se que o pleito autoral deve ser rejeitado, posto não haver evidências científicas de alto nível que demonstrem a eficácia e segurança do medicamento ao tratamento da doença.

Sobre o assunto, colha-se a atual jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

> *"DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO DA NÃO INCORPORAÇÃO PELO CONITEC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 1234 DO STF. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo requerido em face de sentença de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

procedência em ação de obrigação de fazer, em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. O apelante alega a inexistência de imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, com base na ausência de comprovação da ineficácia de tratamentos disponíveis no SUS, na genericidade do laudo médico apresentado e no parecer desfavorável do NAT quanto ao fornecimento dos medicamentos solicitados. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida observou os requisitos estabelecidos no Tema 1234 do STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) avaliar a necessidade de reabertura da instrução para oportunizar às partes a apresentação e análise dos documentos exigidos pela tese fixada no referido tema. O julgamento do Tema 1234 pelo STF estabeleceu requisitos inéditos e obrigatórios para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo a análise do ato administrativo da não incorporação pelo Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, sob pena de nulidade do ato jurisdicional, conforme art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, do CPC. No caso concreto, verifica-se que a sentença de procedência não analisou o ato administrativo de não incorporação pelo Conitec, em violação ao disposto no Tema 1234, item 4, do STF, o que configura nulidade do ato jurisdicional. O Tema 1234, item 4.3, também impõe ao autor da ação o ônus de demonstrar, com base na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. No entanto, não houve, nos autos, a instrução probatória adequada para atender a tais exigências. Ademais, conforme item 4.4 do Tema 1234, não basta a apresentação de relatório médico genérico; exige-se respaldo em evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, o que não foi devidamente comprovado no processo. Considerando a modulação de efeitos do RE 1.366.243/SC, representativo da controvérsia, a competência para processamento do feito não foi deslocada, sendo necessário o retorno dos autos à origem para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

> *reabertura da instrução, com observância das exigências da tese fixada. Remessa necessária não conhecida. Apelação cível provida. Sentença anulada por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, a fim de que seja oportunizado às partes a apresentação e manifestação sobre os documentos exigidos pelo Tema 1234 do STF.* ***O julgamento de pedidos de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige, sob pena de nulidade, a análise do ato administrativo da não incorporação pelo Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa. É ônus do autor demonstrar, com base na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco solicitado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Relatórios médicos genéricos, desprovidos de respaldo em evidências científicas de alto nível, não são suficientes para justificar a concessão judicial de medicamentos não incorporados.*** *Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2023 (Tema 1234).*" (**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0800282-83.2024.8.12.0024, Aparecida do Taboado, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j: 29/04/2025, p: 30/04/2025)

Sendo assim, não resta a este Juízo outro caminho que não seja o de rejeitar as teses arguidas pela parte autora.

A par do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários aos procuradores da parte adversa, estes fixados R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o bom trabalho realizado e o zelo profissional empregado, com fundamento no art. 85, §8º do CPC, tendo em vista tratar-se de causa de pequeno valor e cujo proveito econômico é inestimável. Todavia, suspendo a cobrança de tais verbas, pelo prazo de cinco anos, em razão de sua hipossuficiência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Expeça-se ofício requisitório para pagamento dos honorários periciais (f. 294-298 – R$ 2.400,00).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Se este provimento for objeto de recurso, deverá o cartório observar, de ofício e independentemente de nova conclusão, as disposições gerais dos recursos contidas no art. 994 e ss. do CPC, notadamente o §5º do art. 1.003 de que o lapso temporal para responder é de quinze dias, excetuados os embargos de declaração e ressalvados os prazos em dobro.

Certificado o trânsito em julgado, em não havendo notícia de descumprimento da obrigação estabelecida em sentença, se for o caso, arquivem-se os autos, com baixa.

Às providências.

Camapuã-MS, 10 de fevereiro de 2026.

Daniel Foletto Geller
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL FOLETTO GELLER, liberado nos autos em 10/02/2026 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801542-89.2023.8.12.0006 e código 7Uu9dBtc.